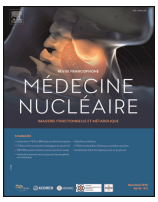
Médecine Nucléaire xx (2026) xxx–xxx

Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com



Lettre à la rédaction

Commentaires sur l'harmonisation SFMN des durées de restriction de contact☆

Comments on the SFMN harmonization of contact restriction durations

Nous avons développé RadIV, un outil web libre d'accès de calcul des durées de restriction de contact après radiothérapie interne vectorisée, destiné aux équipes de médecine nucléaire. RadIV expose une API permettant une intégration directe dans les logiciels de gestion RIS, sous forme de questionnaire structuré interrogeant l'API et injectant automatiquement le résultat dans le compte-rendu du patient. Son mode de calcul local reprend le formalisme décrit par les auteurs [1], lui-même fondé sur le modèle de Carlier et al. [2] et sur le facteur géométrique de Siegel et al. [3].

Nous tenons à remercier chaleureusement les auteurs et le groupe de travail Radioprotection de la SFMN pour ce travail d'harmonisation, particulièrement attendu par la communauté. En intégrant les données du Tableau 1 à notre outil, nous avons été amenés à vérifier chacune des valeurs proposées, ce qui nous conduit à signaler deux points.

Le Tableau 1 indique une demi-vie effective de 30,60 h pour le MIBG-131I, en référence à Wafelman et al. [4]. Une lecture intégrale de cette source primaire ne fait apparaître aucune valeur proche de 30,60 h. Les résultats et la conclusion de cet article indiquent : « The t½ elim […] ranged from 9.1 to 14.3 h (mean ± S.D.: 11.5 ± 1.7 h, n = 11) », avec une distinction par sous-groupe (enfants : 10,6 ± 1,8 h ; adultes : 12,4 ± 1,3 h). Le Tableau 2 de cette publication détaille les 11 valeurs individuelles calculées, dont la plus élevée est 14,3 h. Aucune valeur, individuelle ou moyenne, ne s'approche de 30,60 h. Nous suggérons aux auteurs de vérifier l'origine de cette valeur et d'envisager une correction du Tableau 1.

La section 2.1 décrit le calcul de t_lim comme une grandeur continue, sans préciser la règle de conversion en nombre entier de jours (arrondi au plus proche ou troncature). En comparant notre implémentation aux résultats affichés par l'outil en ligne de référence, les valeurs continues calculées avant arrondi sont identiques pour les 7 scénarios, confirmant la cohérence du modèle décrit [1] ; l'outil de référence semble toutefois tronquer ces valeurs, alors qu'un arrondi au plus proche (également défendable, puisque plus protecteur) produit un résultat différent dans les différents scénarios testés. Dans un objectif d'harmonisation nationale explicitement énoncé par les auteurs [1], il nous semblerait utile de préciser cette convention dans une prochaine mise à jour, afin de garantir la reproductibilité des recommandations entre les outils développés à partir de cette méthodologie.

Déclaration relative à l'IA générative et aux technologies assistées par l'IA dans le processus de préparation des manuscrits

Au cours de la préparation de ce travail, le ou les auteurs ont utilisé Claude (Anthropic) pour les aider à rédiger cette lettre et à développer l'application web RadIV mentionnée dans cette correspondance. Le ou les auteurs ont relu et corrigé le texte si nécessaire et assument l'entière responsabilité du contenu de l'article publié.

Déclaration de liens d'intérêts

L'auteur déclare ne pas avoir de liens d'intérêts.

Références

[1] Carlier T, Denizot B, Prevot-Bitot N, Nioche C, Courbon F, Cachin F. Harmonization of exposure constraints for relatives following targeted radionuclide therapy: a French perspective. Med Nucl. 2026;50:131–6.
[2] Carlier T, Lisbona A, Kraeber-Bodere F, Ansquer C, Couturier O. Recommandations pratiques concernant la sortie des patients après traitement du cancer différencié de la thyroïde à l'131I. Radioprotection. 2004;39:481–92.
[3] Siegel JA, Kroll S, Regan D, Kaminski MS, Wahl RL. A practical methodology for patient release after tositumomab and (131)I-tositumomab therapy. J Nucl Med. 2002;43:354–63.
[4] Wafelman AR, Nortier YLM, Rosing H, Maessen HJM, Taal BG, Hoefnagel CA, et al. Renal excretion of meta-iodobenzylguanidine after therapeutic doses in cancer patients and its relation to dose and creatinine clearance. Nucl Med Commun. 1995;16:767–72.

Jean-Cyril Bourre

Service de médecine nucléaire, CH Métropole Savoie, BP 31125, 73011 Chambéry cedex, France

Adresse e-mail: jean-cyril.bourre@ch-metropole-savoie.fr

DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.mednuc.2026.03.002.

☆ A propos de : Carlier T, Denizot B, Prevot-Bitot N, Nioche C, Courbon F, Cachin F. Harmonization of exposure constraints for relatives following targeted radionuclide therapy: A French perspective. Médecine Nucléaire 2026. http://doi.org/10.1016/j.mednuc.2026.03.002 [1].

https://doi.org/10.1016/j.mednuc.2026.10.002
0928-1258/© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés, y compris ceux relatifs à la fouille de textes et de données, à l'entraînement de l'intelligence artificielle et aux technologies similaires.

Pour citer cet article : J.-C. Bourre, Commentaires sur l'harmonisation SFMN des durées de restriction de contact, Médecine Nucléaire. https://doi.org/10.1016/j.mednuc.2026.10.002

Téléchargé pour Anonymous User (n/a) à Savoie-Belley Territory Hospital Group à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur octobre 30, 2026.
Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2026. Elsevier Inc. Tous droits réservés.